

Amigdalitis de repetición y criterios de amigdalectomía

1. Introducción y relevancia clínica

La **amigdalitis de repetición** se define como la **infección recurrente de las amígdalas palatinas**, caracterizada por episodios repetidos de odinofagia, fiebre, y signos inflamatorios locales.

Es una de las causas más frecuentes de consulta en pediatría y otorrinolaringología, y constituye la **principal indicación de amigdalectomía electiva** en niños.

Relevancia clínica

- Representa una causa relevante de **ausentismo escolar** y **uso reiterado de antibióticos**.
 - La decisión de realizar una **amigdalectomía** debe ser **criteriada**, ya que la mayoría de las infecciones son autolimitadas.
 - Un manejo adecuado reduce complicaciones, resistencia antibiótica y cirugías innecesarias.
 - En el **EUNACOM**, este tema es altamente evaluado por su frecuencia y su relación con la cirugía otorrinolaringológica más practicada en Chile.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Función fisiológica de las amígdalas

Las amígdalas palatinas forman parte del **anillo linfático de Waldeyer**, junto con las adenoides y amígdalas linguales.

Su función es **inmunológica**, actuando como una **barrera primaria** frente a patógenos inhalados o ingeridos, especialmente en los primeros años de vida.

- Contienen **folículos linfoides** con células B y T.
- Participan en la **respuesta inmune local** durante la infancia.
- Su actividad inmunológica disminuye después de la pubertad.

2.2 Fisiopatología de la infección recurrente

1. **Colonización crónica del criptas amigdalares** por *Streptococcus β -hemolítico grupo A* (SBHGA) u otras bacterias.
2. Alteración del drenaje de las criptas → retención de detritus → inflamación persistente.
3. Ciclos repetidos de infección aguda → fibrosis y alteración estructural del tejido amigdalar.
4. En algunos casos, coexistencia con **adenoiditis crónica** o **sinusitis crónica** como foco de reinfección.

2.3 Factores predisponentes

- Edad infantil (5–15 años).
- Exposición a ambientes escolares o comunitarios.
- Alergias respiratorias crónicas.
- Hipertrofia adenoidea o respirador bucal crónico.
- Portadores asintomáticos de SBHGA.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas

- Episodios recurrentes de **odinofagia intensa**, fiebre alta (>38,5°C).
- **Amígdalas hipertróficas, eritematosas, con o sin exudado purulento.**
- **Halitosis** frecuente (por detritus o caseum amigdalar).
- **Adenopatías laterocervicales** dolorosas recurrentes.

- **Ronquido o respiración bucal crónica** si hay hipertrofia obstructiva.
 - Fatiga y bajo rendimiento escolar en cuadros persistentes.
-

3.2 Definición de amigdalitis recurrente (criterios clínicos)

Criterios modificados de Paradise (MINSAL / AAO-HNS):

- **≥7 episodios** de amigdalitis aguda en el último año, o
 - **≥5 episodios/año** en los últimos **2 años consecutivos**, o
 - **≥3 episodios/año** en los últimos **3 años consecutivos**,
- y cada episodio documentado debe incluir al menos uno de los siguientes:
1. Fiebre >38.3°C.
 2. Exudado o eritema amigdalár.
 3. Adenopatías cervicales dolorosas.
 4. Test o cultivo positivo para SBHGA.
 5. Tratamiento antibiótico documentado.

Si los registros clínicos son incompletos, se recomienda observación y seguimiento por 6–12 meses antes de considerar cirugía.

3.3 Diagnóstico diferencial

Patología	Diferenciación clave
Faringitis viral recurrente	Cuadros leves, con síntomas catarrales.
Mononucleosis infecciosa	Linfocitosis atípica, esplenomegalia, fiebre prolongada.

Absceso periamigdalino recurrente	Dolor unilateral intenso, trismus, desviación de úvula.
Sinusitis crónica / adenoiditis	Rinorrea posterior y obstrucción nasal persistente.
Reflujo laringofaríngeo	Odinofagia matinal, sin fiebre ni exudado.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación en APS

- Diagnóstico **principalmente clínico**.
- Se recomienda documentar cada episodio: fiebre, exudado, cultivo o test rápido.
- No se justifica estudio complementario en cada cuadro leve.

4.2 Estudios complementarios según contexto

Examen	Utilidad
Test rápido de antígeno para SBHGA	Confirmar etiología bacteriana.
Cultivo faríngeo	Si test rápido negativo pero clínica compatible.
Hemograma	Neutrofilia en bacteriana; linfocitosis en viral.
Monotest (VEB)	Si sospecha mononucleosis infecciosa.
Nasofibroscofia	Si hay obstrucción nasal importante o ronquido.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Tratamiento médico

Indicado en la mayoría de los casos y siempre antes de plantear cirugía.

a) Tratamiento antibiótico de los episodios agudos:

- **Penicilina benzatina IM dosis única, o**
- **Amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días.**
- **En alérgicos: macrólidos (azitromicina 3 días o claritromicina 10 días).**

b) Medidas generales:

- Analgésicos/antipiréticos (paracetamol o ibuprofeno).
- Hidratación y reposo relativo.
- Control de rinitis alérgica o reflujo asociado.
- Educación sobre higiene oral y cambio de cepillo tras infección.

c) Portador crónico de SBHGA:

- Erradicación con **amoxicilina + ácido clavulánico por 10 días o clindamicina 10 días.**

5.2 Tratamiento quirúrgico: Amigdalectomía

Indicaciones absolutas (MINSAL / AAO-HNS):

1. **Amigdalitis recurrente documentada** según criterios de Paradise.
2. **Absceso periamigdalino recurrente o bilateral.**
3. **Obstrucción de vía aérea superior** por hipertrofia amigdalar (apneas, ronquido severo).

4. **Sospecha de neoplasia amigdalal.**
5. **Mal aliento (halitosis severa)** con caseum persistente refractario.

Indicaciones relativas:

- Dificultad para alimentarse o hablar por hipertrofia.
 - Trastornos del sueño moderados.
 - Reincidencia pese a tratamientos médicos adecuados.
-

Contraindicaciones (relativas o absolutas):

Tipo	Ejemplo
Absolutas	Trastorno grave de coagulación no corregido.
Relativas	Infección activa (aplazar cirugía), mal control de asma o diabetes.

Técnica quirúrgica (amigdalectomía clásica)

- Anestesia general.
 - Resección completa de ambas amígdalas.
 - Hemostasia con electrocauterio o sutura.
 - Duración: 30–45 minutos.
-

Cuidados postoperatorios

- Dieta blanda, fría o tibia (evitar alimentos duros o calientes).

- Hidratación abundante.
- Analgésicos (paracetamol, evitar AINEs los primeros días).
- Control a los 7–10 días.
- Signos de alarma: sangrado, fiebre, dificultad para tragar líquidos.

5.3 Complicaciones de la cirugía

Complicación	Frecuencia	Descripción
Hemorragia postoperatoria	2–5%	Inmediata (<24 h) o secundaria (5–10 días).
Dolor intenso / disfagia	Muy común	Dura 7–10 días.
Deshidratación	Por rechazo a líquidos.	
Infección del lecho quirúrgico	Rara	Fiebre, halitosis.
Regurgitación nasal	Transitoria por edema palatino.	

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones de la enfermedad no tratada

- Abscesos periamigdalinos o retrofaríngeos.
- Fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica.
- Síndrome de apnea obstructiva del sueño.

- Impacto en crecimiento y rendimiento escolar.

6.2 Pronóstico

- Excelente tras cirugía bien indicada: disminución significativa de infecciones y síntomas obstructivos.
 - La recurrencia es baja (menos del 5%).
 - La función inmunológica no se ve comprometida de forma significativa después de la amigdalectomía.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Aplicar **criterios de Paradise** antes de indicar amigdalectomía.
 2. **SBHGA** es el principal agente bacteriano de las recurrencias.
 3. **Penicilina o amoxicilina** siguen siendo primera línea.
 4. En niños con **ronquido y respiración bucal**, evaluar **adenoamigdalectomía**.
 5. **Evitar cirugía durante un cuadro infeccioso activo.**
 6. **Sangrado postoperatorio entre el 5.º y 10.º día** requiere **derivación inmediata a urgencias.**
 7. La cirugía **no elimina completamente las infecciones virales** de faringe, pero reduce la frecuencia.
-

Errores comunes

- Indicar amigdalectomía por 2–3 episodios leves sin documentación.
- Omitir registro clínico de episodios y antibióticos usados.
- Tratar mononucleosis con amoxicilina (rash).

- No instruir al paciente sobre signos de alarma postoperatorios.
 - Operar durante una infección activa o sin control de comorbilidades.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **amigdalitis de repetición** se define por episodios frecuentes documentados según **criterios de Paradise**.
2. El **Streptococcus β -hemolítico grupo A** es el agente bacteriano más relevante.
3. El tratamiento inicial es **médico**, con **penicilina o amoxicilina** y medidas de apoyo.
4. La **amigdalectomía** está indicada en infecciones recurrentes documentadas o complicadas, y en casos de **obstrucción respiratoria**.
5. El pronóstico postquirúrgico es **excelente**, con baja tasa de recurrencia.
6. **Sangrado postoperatorio** es la complicación más grave y requiere atención urgente.
7. En EUNACOM, recordar: **criterios de Paradise, indicaciones quirúrgicas absolutas, y manejo postoperatorio básico**.